



Caminhos
Brilhantes

RELATÓRIO TÉCNICO

Jornada de Cuidado no *Neurodesenvolvimento* *Infantil*

Uma Frente do Programa Caminhos Brilhantes

Onde Esta Jornada *Se Encaixa*

Caminhos Brilhantes é a estratégia de atenção à saúde da Unimed Governador Valadares para o cuidado integral ao Transtorno do Espectro Autista e condições correlatas.

A estratégia articula gerenciamento populacional, qualificação de rede, inovação tecnológica e novos modelos de remuneração, com o framework do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. A estratégia se organiza em três eixos articulados, que operam de forma sinérgica.

EIXO 01 - ACESSO E REDE

Garantia de Acesso e Qualificação de Rede

A rede que recebe a criança, ampliada e submetida a padrão de qualidade verificável.

O QUE REÚNE

- Ambulatório de Avaliação Diagnóstica no CAI, em operação desde 2 de setembro de 2026
- Casa Unimed e Centro de Terapias Especiais ampliado
- Credenciamento com anexo assistencial vinculado a indicadores
- Casa Unimed e clínicas credenciadas certificadas pelo Programa Quális

EIXO 02 - CUIDADO COORDENADO

Cuidado Coordenado, Integral e Integrado

O percurso da criança e da família entre os pontos de atenção, com navegação contínua.

O QUE REÚNE

- Atenção primária integrada com autorização e auditoria
- Pré-triagem do AAD com estratificação de complexidade
- Linha de cuidado do TEA vinculada ao plano terapêutico da Casa Unimed
- Encontros mensais com famílias em parceria com o IBRAVS

EIXO 03 - DESFECHOS E VALOR

Eficiência, Desfechos e Melhoria Contínua

A medição do resultado e o modelo de remuneração que dela decorre.

O QUE REÚNE

- Framework IBRAVS desenvolvido no âmbito do acordo de cooperação técnica com a ANS
- Gerenciamento populacional pelo Escritório de Valor em Saúde
- Saída do *fee-for-service*, com modelo híbrido em 2027
- Mensuração de desfechos via PROMs e PREMs

Eixo 02

Este documento detalha o **Cuidado Coordenado** — o percurso da criança e da família dentro da linha de cuidado do neurodesenvolvimento infantil.

Os eixos de acesso e rede e de desfechos e valor aparecem aqui apenas quando tocam esse percurso, e são objeto de material próprio.

O Percurso *do Documento*

Quatorze seções, organizadas em três blocos: o enquadramento e a arquitetura, as estações do percurso e a camada de pactuação e governança.

BLOCO I · ENQUADRAMENTO E ARQUITETURA

01	O Programa e Seus Três Eixos	02
	Três eixos articulados, uma frente detalhada	
02	A Fragmentação Que a Jornada Resolve	04
	O que o percurso desenhado corrige	
03	Arquitetura da Jornada	05
	Cinco estações e uma base institucional	

BLOCO II · AS ESTAÇÕES E A CLUSTERIZAÇÃO

04	Estação 01 · Status Quo	06
	Onde o paciente vive	
05	Estação 02 · Rastreo e Suspeição na Pediatria	07
	A pediatria como porta de rastreo	
06	Estação 03 · Central de Coordenação do Cuidado	08
	Regulação, navegação e referência de apoio	
07	Clusterização · Os Três Instrumentos	09
	Três instrumentos, três perguntas distintas	
08	Matriz de Clusters	10
	A combinação que define o cluster	
09	Estação 04 · Ambulatório de Avaliação Diagnóstica	11
	Recurso próprio no Centro de Atendimento Integrado	
10	Códigos de Demanda	12
	Cem por cento entram no Visualizador Clínico	
11	Estação 05 · Encaminhamentos	13
	Destinos combináveis na rede assistencial	

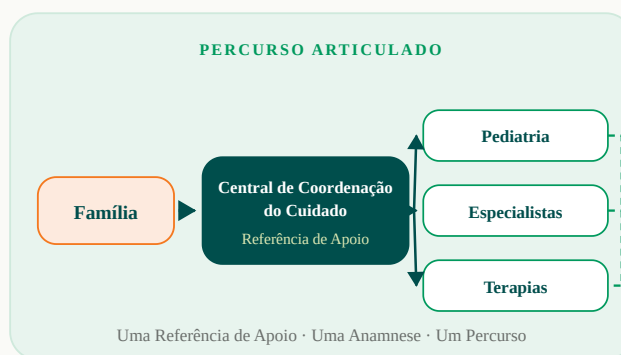
BLOCO III · PACTUAÇÃO E GOVERNANÇA

12	Intensidade Terapêutica	14
	A proporção governa, o número absoluto se ajusta	
13	Desfechos e Acompanhamento	15
	Instrumentos de desfecho: ATEC e QoLA	
14	Governança e Parcerias	16
	O que sustenta a jornada	

A Fragmentação Que a Jornada Resolve

Sem um percurso desenhado, o cuidado da criança com suspeita de TEA se organiza por iniciativa isolada.

A família busca a porta de entrada que conhece, repete a história clínica em cada ponto e acumula avaliações que não conversam entre si. O tempo entre o primeiro sinal e o início da terapia se alonga enquanto a visão do percurso inteiro permanece dispersa.



À ESQUERDA, O ACESSO POR INICIATIVA ISOLADA · À DIREITA, O PERCURSO ARTICULADO COM A CENTRAL DE COORDENAÇÃO DO CUIDADO COMO REFERÊNCIA DE APOIO

01

ACESSO

Porta de Entrada Difusa

A família navega sozinha entre pediatria, especialistas e terapias. Cada acesso recomeça a anamnese.

02

AValiação

Aplicação Heterogênea

Instrumentos aplicados sem padrão produzem laudos incomparáveis entre si, que deixam a decisão de intensidade terapêutica sem base.

03

DESFECHO

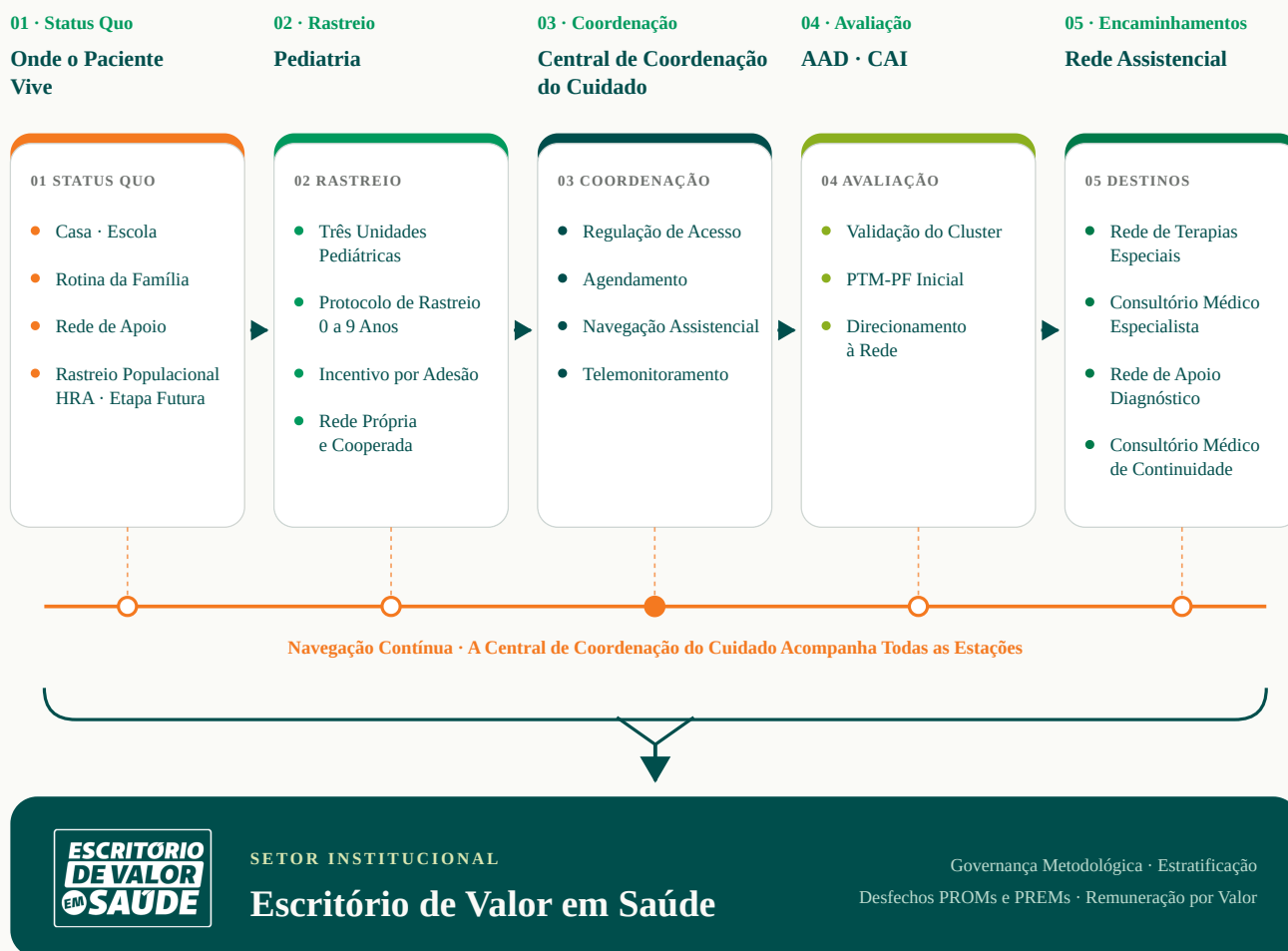
Medição Ausente

Sem instrumento de acompanhamento pactuado, o resultado da terapia permanece fora do registro longitudinal e a remuneração segue atrelada ao volume.

A resposta do desenho. A jornada responde a cada frente com um elemento próprio: a Central de Coordenação do Cuidado como referência de apoio e navegação, os três instrumentos de clusterização como padrão de avaliação, e os instrumentos de desfecho como base da remuneração por valor.

Cinco Estações e uma Base

O percurso se lê da esquerda para a direita, com a Central de Coordenação do Cuidado atravessando todas as estações e o Escritório de Valor em Saúde na base.



CINCO ESTAÇÕES DA JORNADA · O TRILHO LARANJA É A NAVEGAÇÃO CONTÍNUA DA CENTRAL · A CHAVE INFERIOR REÚNE AS ESTAÇÕES SOBRE O ESCRITÓRIO DE VALOR EM SAÚDE

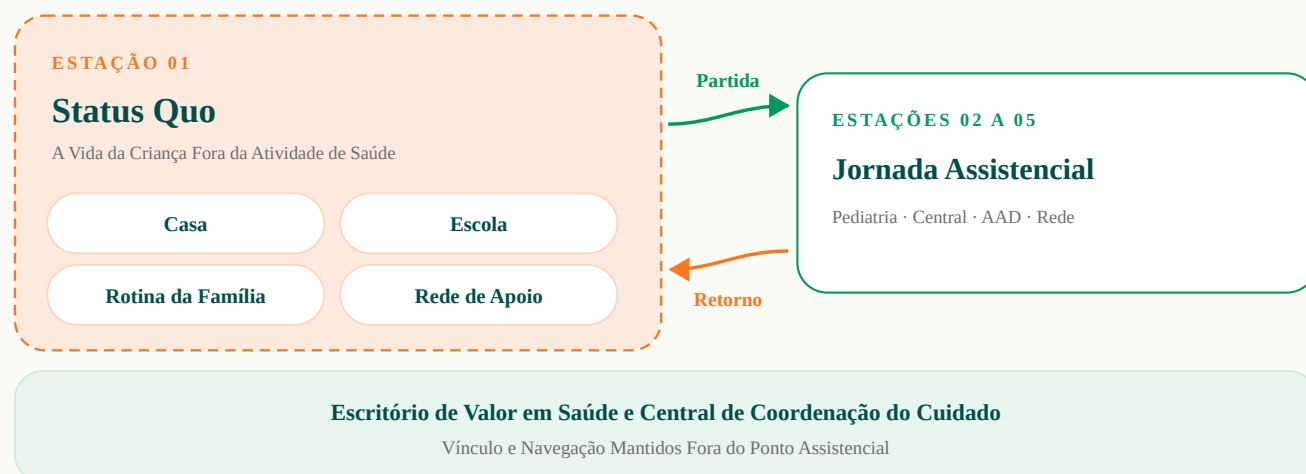
O percurso se lê da esquerda para a direita, e a sua ordem no tempo é outra. A navegação da Central de Coordenação do Cuidado atravessa todas as estações de forma contínua: a criança já está navegada antes de chegar à avaliação diagnóstica, e segue navegada depois dela.

O Escritório de Valor em Saúde sustenta as estações como base institucional, com governança metodológica, estratificação, medição de desfechos e remuneração por valor. A chave que fecha o diagrama representa esse vínculo.

Onde o Paciente *Vive*

O Status Quo designa qualquer lugar onde a criança está fora de atividade de saúde: a casa, a escola, a rotina da família.

A jornada parte dali e retorna para lá. Tratar o Status Quo como estação do percurso reconhece que a maior parte da vida da criança acontece fora dos pontos assistenciais, e que a rede de apoio familiar e escolar participa do cuidado.



A JORNADA PARTE DO STATUS QUO E RETORNA A ELE · O VÍNCULO COM O ESCRITÓRIO DE VALOR EM SAÚDE E COM A CENTRAL PERMANECE EM TODO O INTERVALO

ELEMENTO 01

Rastreio Populacional · HRA

A busca ativa de sinais precoces por Health Risk Assessment está prevista como desenvolvimento posterior.

ETAPA FUTURA

- Permitirá identificar a criança antes que a família procure atendimento

ELEMENTO 02

Vínculo Mantido Fora do Ponto Assistencial

A criança permanece sob acompanhamento mesmo fora da atividade de saúde.

EM OPERAÇÃO

- O Escritório de Valor em Saúde e a Central de Coordenação do Cuidado mantêm o vínculo e a navegação

A extensão do termo. O Status Quo abrange toda a vida da criança fora da atividade de saúde, com destaque para os ambientes escolar e familiar, onde os sinais frequentemente aparecem primeiro.

A Pediatria Como *Porta de Rastreio*

A pediatria da atenção primária converte o sinal precoce em suspeição formal.

Três unidades pediátricas participam do rastreio, integradas ao mesmo protocolo, em rede própria e cooperativa. O mesmo protocolo torna a suspeição comparável entre elas e faz o encaminhamento chegar à Central de Coordenação do Cuidado com o mesmo padrão de informação.

01

UNIDADE PEDIÁTRICA

Rastreio e Suspeição

Rede própria e cooperativa, sob o protocolo comum.

02

UNIDADE PEDIÁTRICA

Rastreio e Suspeição

Rede própria e cooperativa, sob o protocolo comum.

03

UNIDADE PEDIÁTRICA

Rastreio e Suspeição

Rede própria e cooperativa, sob o protocolo comum.

0 a 9

São os anos de idade cobertos pelo **Protocolo de Rastreio** – o incentivo por adesão aproxima a aplicação do protocolo da rotina da consulta pediátrica.

A janela de validação do instrumento. O protocolo cobre a faixa de zero a nove anos. O M-CHAT-R/F, instrumento de rastreio específico do TEA, tem validação para a janela de 16 a 30 meses; fora dela, o protocolo se apoia nos marcos do desenvolvimento e no julgamento clínico do pediatra.

O incentivo por adesão aproxima o rastreio da rotina da consulta pediátrica. Identificada a suspeição, o caso segue para a Central de Coordenação do Cuidado, que assume a navegação a partir daquele ponto.

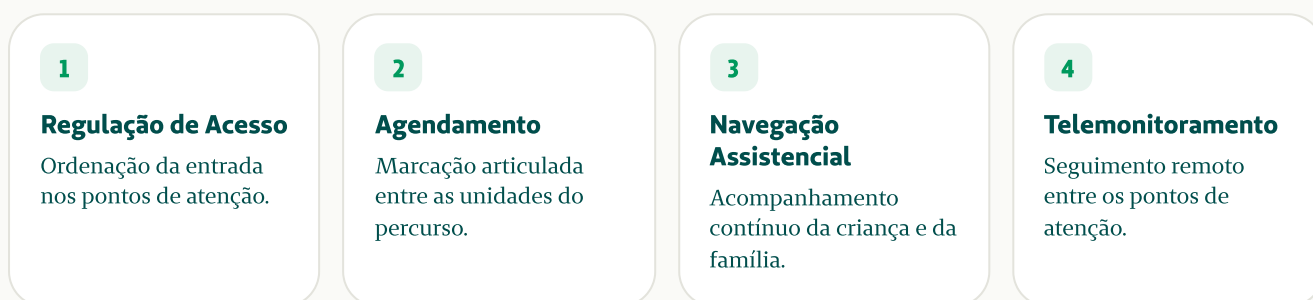


DO SINAL NO STATUS QUO ATÉ A ENTRADA NA CENTRAL · A SUSPEIÇÃO FORMAL É O GATILHO QUE TRANSFERE A CONDUÇÃO DO CASO

Regulação, Navegação e Referência de Apoio

A Central de Coordenação do Cuidado é a célula centralizada de regulação de acesso, agendamento, navegação assistencial e telemonitoramento entre os pontos de atenção.

Para a família, a Central é a referência de apoio: o lugar onde um problema do percurso se resolve, sem que ela precise descobrir sozinha qual unidade procurar. Os canais regulamentares de atendimento da operadora seguem à disposição do beneficiário. A Central atua como coordenadora do percurso, e a coordenação se distingue do controle de acesso: o objetivo é articular, acompanhar e destravar, com responsabilidade sobre a continuidade do cuidado.



TODAS AS UNIDADES ASSISTENCIAIS SE COMUNICAM COM A CENTRAL, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA

A interface administrativa do percurso. Autorização e auditoria são atribuição da Auditoria em Saúde, área distinta da Central. Cem por cento das demandas entram no Visualizador Clínico, o que dá à Central uma base única de acompanhamento.

A navegação é contínua ao longo do percurso. A criança já está navegada antes de chegar ao Ambulatório de Avaliação Diagnóstica e permanece navegada depois. A Central acompanha todos os pontos.

Três Instrumentos, Três Perguntas Distintas

A clusterização combina três instrumentos com finalidades próprias, e a combinação das três respostas define o cluster.

Fase	Instrumento	O Que Mede	Formato
Fase 1	M-CHAT-R/F	Rastreo de sinais de TEA	Questionário aos responsáveis · 20 itens · 16 a 30 meses · com entrevista de seguimento
Fase 2	CARS	Gravidade dos sintomas	15 itens · aplicação por clínico treinado
Fase 3	CBDF	Funcionalidade e participação	Classificação fundamentada nos qualificadores da CIF

Cada linha responde a uma pergunta diferente sobre a mesma criança, e nenhuma delas substitui as outras duas.



AS TRÊS FASES DA CLUSTERIZAÇÃO · RASTREIO, GRAVIDADE E FUNCIONALIDADE CONVERGEM NA DEFINIÇÃO DO CLUSTER

A Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos foi instituída pela Resolução COFFITO 610/2025 e adota os qualificadores da Classificação Internacional de Funcionalidade da Organização Mundial da Saúde. Descreve funcionalidade e participação, e dialoga com o CID e com sistemas de agrupamento como o DRG. A sua contribuição à clusterização está na dimensão funcional, distinta do rastreo e da graduação de sintomas.

Onde os instrumentos são aplicados. Os três instrumentos podem ser aplicados no Status Quo ou na rede de apoio, conforme a decisão da Central de Coordenação do Cuidado, que orchestra a sequência em alça fechada.

O que a CARS gradua. A CARS gradua a intensidade dos sintomas. Os níveis de suporte 1, 2 e 3 são construído do DSM-5 e seguem critério clínico próprio.

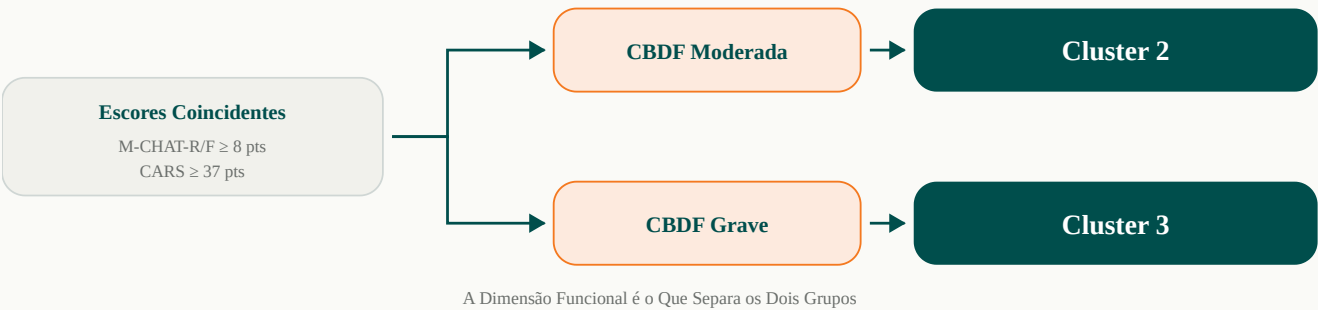
A Combinação Que Define o Cluster

A matriz pactuada com o IBRAVS em 20 de agosto de 2026 organiza quatro clusters de complexidade, que orientam o plano terapêutico de cada criança.

Cluster	M-CHAT-R/F	CARS	CBDF
0 - Suspeita	0 a 2 pts	≤ 30 pts	Sem Disfunção
1	3 a 7 pts	31 a 36 pts	Leve
2	≥ 8 pts	≥ 37 pts	Moderada
3	≥ 8 pts	≥ 37 pts	Grave

As duas últimas linhas repetem os mesmos escores de rastreio e de gravidade, e é a terceira coluna que as distingue.

O papel da dimensão funcional. A CBDF diferencia os clusters 2 e 3, cujos escores de rastreio e gravidade coincidem. A dimensão funcional é o que separa os dois grupos.



O MESMO PAR DE ESCORES SE ABRE EM DOIS CLUSTERS DISTINTOS CONFORME A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

IBRAVS

Matriz de Alocação de Recursos Terapêuticos – pactuada em 20 de agosto de 2026, é a peça que traduz a avaliação da criança em plano terapêutico.

AAD • CAI *Recurso Próprio*

O Ambulatório de Avaliação Diagnóstica funciona no Centro de Atendimento Integrado, em recurso próprio da operadora.

É onde a avaliação se consolida e o plano terapêutico é pactuado.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

60

Crianças por mês

AGENDA

Dois turnos

Por semana

EM OPERAÇÃO DESDE

2 de setembro

de 2026

ENTREGA 01

Validação do Cluster

Inclusão ou exclusão a partir dos três instrumentos aplicados.

O QUE DECORRE

- O ambulatório confirma o cluster e define o encaminhamento na rede

ENTREGA 02

PTM-PF Inicial

Plano Terapêutico Multidisciplinar Pactuado com a Família, construído no ambulatório e direcionado à rede.

LINHA DE BASE

- O QoLA é aplicado no momento da pactuação

Suspeição Formal

Rastreio na Pediatria



Cinco Semanas

Meta Pactuada



Pactuação do PTM-PF

Plano Terapêutico Construído no AAD

DA SUSPEIÇÃO FORMAL NA PEDIATRIA À PACTUAÇÃO DO PLANO TERAPÊUTICO NO AMBULATÓRIO

A meta de tempo do percurso. A meta pactuada é de cinco semanas entre a suspeição e a pactuação do plano terapêutico.

Cem Por Cento Entram no Visualizador Clínico

A triagem na Central de Coordenação do Cuidado recebe as solicitações de terapia e os encaminhamentos por uma entrada única.

CÓDIGOS DE DEMANDA

7

Entradas mapeadas no painel da jornada

SEGUEM AO AAD

5

Os demais permanecem gerenciados no Visualizador Clínico

ENTRADA JUDICIAL

2

Códigos 3 e 4C, com o mesmo tratamento assistencial

Cód.	O Que	De Quem	Como	Segue ao AAD
1A	Solicitação de Terapias Especiais	Neuropediatra ou Psiquiatra	Início de Atendimento	ELEGÍVEL
1B	Solicitação de Terapias Especiais	Neuropediatra ou Psiquiatra	Renovação	GERENCIADO
2	Solicitação de Terapias Especiais	Clínica Prestadora	Renovação	GERENCIADO
3	Solicitação de Terapias Especiais	Jurídico	Liminar · Início de Tratamento	ELEGÍVEL
4A	Encaminhamento a Neuropediatra	Pediatra ou MFC · Hipótese Diagnóstica de TEA	Diagnóstico	ELEGÍVEL
4B	Encaminhamento a Psiquiatra	Pediatra ou MFC · Hipótese Diagnóstica de TEA	Diagnóstico	ELEGÍVEL
4C	Acesso a Neuropediatra ou Psiquiatra	Jurídico	Liminar	ELEGÍVEL

A coluna da direita separa o que segue à avaliação diagnóstica do que permanece em acompanhamento pela Central.

A leitura da tabela. Cinco dos sete códigos seguem ao Ambulatório de Avaliação Diagnóstica. Os códigos de renovação permanecem gerenciados no Visualizador Clínico até a próxima oportunidade de avaliação.

A via judicial dentro do percurso. Duas das sete entradas chegam por via judicial. A triagem única no Visualizador Clínico dá a essas demandas o mesmo tratamento assistencial das demais.

Encaminhamentos *na Rede Assistencial*

A saída do Ambulatório de Avaliação Diagnóstica se abre em quatro destinos.

Conforme o plano pactuado, a criança segue para um, alguns ou todos eles, na rede assistencial própria, credenciada e cooperada.

DESTINO 01

Rede de Terapias Especiais

Casa Unimed, em recurso próprio, e as clínicas credenciadas certificadas pelo Programa Quálux.

COMPOSIÇÃO

- Casa Unimed · Recurso próprio
- Clínicas credenciadas · Certificação Quálux
- O PTM-PF direciona a intensidade em cada caso

DESTINO 02

Consultório Médico Especialista

Co-manejo medicamentoso com o Centro de Terapias Especiais.

NATUREZA

- Ato médico dedicado

DESTINO 03

Rede de Apoio Diagnóstico

Propedêutica complementar e avaliação neuropsicológica conforme indicação do plano terapêutico.

ACIONAMENTO

- Conforme indicação do plano terapêutico

DESTINO 04

Consultório Médico de Continuidade

Seguimento a cada seis meses, com caráter distinto do da avaliação diagnóstica.

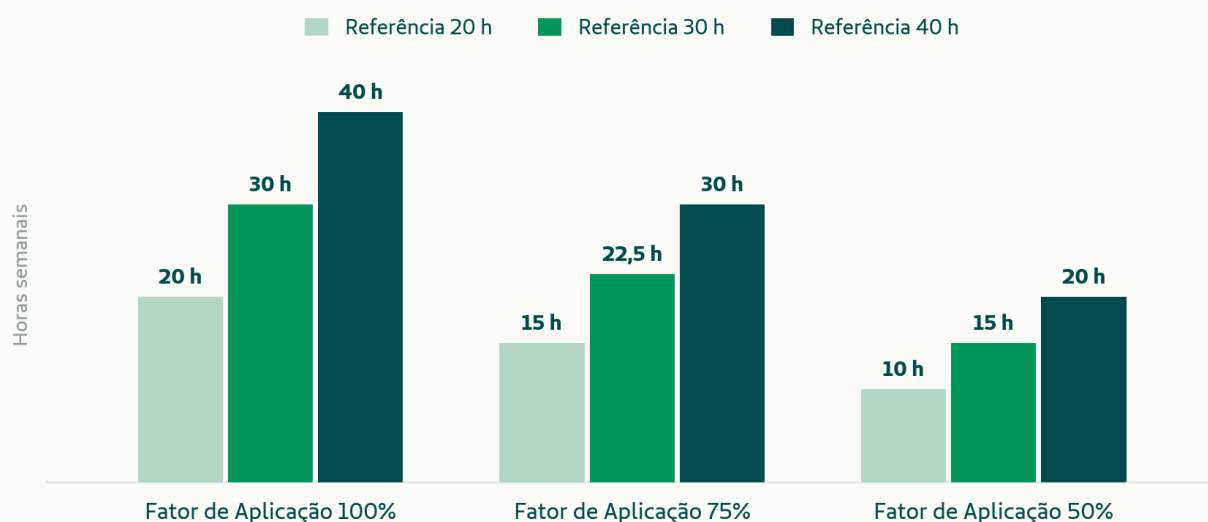
VÍNCULO COM A CENTRAL

- Mantém contato permanente com a Central de Coordenação do Cuidado
- Devolve ao percurso a informação do acompanhamento longitudinal

Três atos médicos distintos. Os três destinos de atividade médica correspondem a atos médicos distintos, com finalidade própria em cada ponto do percurso.

A Proporção Governa, o Número Absoluto Se Ajusta

A intensidade terapêutica varia por cluster, e o que a jornada normatiza é a proporção entre os clusters. A razão pactuada é de dois para três para quatro.



CARGA SEMANAL POR CLUSTER SOB OS TRÊS FATORES DE APLICAÇÃO · A DISTÂNCIA ENTRE AS BARRAS PERMANECE A MESMA NOS TRÊS GRUPOS

Nível	Razão	100% · Referência	75%	50%
TEA 1	2	20 h/sem	15 h/sem	10 h/sem
TEA 2	3	30 h/sem	22,5 h/sem	15 h/sem
TEA 3	4	40 h/sem	30 h/sem	20 h/sem

Os valores de vinte, trinta e quarenta horas semanais funcionam como referência. Sobre eles incide um fator de aplicação institucional de cem, setenta e cinco ou cinquenta por cento, definido conforme a maturidade do programa e a capacidade de atendimento instalada. As horas absolutas se ajustam a cada cenário, e a razão de dois para três para quatro permanece constante.

O que o fator de aplicação responde. O fator de aplicação responde a duas frentes simultâneas: a construção de uma cultura de amadurecimento na pactuação com a rede e o dimensionamento realista da capacidade instalada.

O acompanhamento médico fora da escala. As consultas médicas de acompanhamento permanecem em quatro por ano nos três clusters, sem escalonamento pela proporção terapêutica.

Instrumentos de Desfecho

O acompanhamento da criança e da família se apoia em dois instrumentos com ciclos e objetos distintos.

INSTRUMENTO 01

ATEC

Autism Treatment Evaluation Checklist. Acompanha a evolução da criança em 77 itens distribuídos por quatro subescalas.

SUBESCALAS

- Fala, Linguagem e Comunicação
- Sociabilidade
- Consciência Sensorial e Cognitiva
- Saúde, Física e Comportamento
- Preenchido por pais, professores ou cuidadores

INSTRUMENTO 02

QoLA - Parte A

Quality of Life in Autism. A Parte A mede a qualidade de vida do cuidador e sustenta o uso como indicador de desfecho.

APLICAÇÃO

- Aplicada na pactuação do plano terapêutico como linha de base
- Repetida em ciclo semestral

COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES INSTITUCIONAIS

Instrumento	Dimensão	Peso no Conjunto
ATEC	Fala, Linguagem e Comunicação	10%
ATEC	Sociabilidade	10%
ATEC	Consciência Sensorial e Cognitiva	10%
ATEC	Saúde, Física e Comportamento	10%
QoLA - Parte A	Qualidade de Vida do Cuidador	Benchmark ≥ 10% de melhora

A leitura dos pesos. Os pesos de dez por cento se referem à composição do conjunto de indicadores institucionais. A pontuação interna do ATEC distribui os 77 itens de forma desigual entre as quatro subescalas.

QOLA - APLICAÇÃO EM CICLO SEMESTRAL



O QOLA PARTE DA LINHA DE BASE FIXADA NA PACTUAÇÃO DO PLANO TERAPÊUTICO E SE REPETE A CADA SEIS MESES

A escolha de medir a qualidade de vida do cuidador reconhece que o resultado do cuidado no neurodesenvolvimento infantil se manifesta também no núcleo familiar. O ciclo semestral acompanha a trajetória com espaçamento compatível com a rotina da família.

O Que Sustenta a Jornada

A Gestão de Provimento de Saúde coordena três áreas com atribuições distintas, e a jornada se apoia nas três.

1

Escritório de Valor em Saúde

Núcleo metodológico e analítico. Linhas de cuidado, saúde baseada em valor, acordos baseados em valor, produção científica, indicadores de qualidade assistencial, desfechos reportados por pacientes e governança do Data Warehouse.

2

Central de Coordenação do Cuidado

Regulação de acesso, agendamento, navegação assistencial e telemonitoramento entre os pontos de atenção.

3

Auditoria em Saúde

Autorização e auditoria pré e pós-pagamento. Área distinta do Escritório de Valor em Saúde e da Central de Coordenação do Cuidado.



SETOR INSTITUCIONAL

Escritório de Valor em Saúde

01

Governança Metodológica

02

Estratificação

03

Desfechos PROMs e PREMs

04

Produção Científica

05

Remuneração por Valor

FRAMEWORK DE VALOR

IBRAVS

Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. Framework desenvolvido no âmbito do acordo de cooperação técnica com a ANS. Cadência quinzenal e modelo de quatro camadas de incentivo.

CERTIFICAÇÃO DE REDE

FEMG · Programa Quális

Unimed Federação Minas. Auditoria externa dos Centros de Terapias Especiais de 15 a 17 de junho de 2026 e certificação em 14 de agosto de 2026, após avaliação de 96 requisitos. A Casa Unimed recebeu o Selo Ouro.

PLATAFORMA

Neurosteps

Plataforma parceira da Unimed do Brasil, em operação. Jornada terapêutica, engajamento familiar, PROMs e PREMs.

A estratificação por cluster e a medição de desfechos por ATEC e QoLA formam a base sobre a qual a remuneração por valor se apoia. O desenho vincula a contraprestação ao resultado observado na criança e no cuidador, com saída progressiva do *fee-for-service* e modelo híbrido previsto para 2027.

O QUE ESTE RELATÓRIO NÃO RESPONDE

- O dimensionamento de demanda elegível depende de apuração na base de dados da operadora.
- A fórmula de vinculação entre desfechos e remuneração será objeto de documento próprio.
- O impacto financeiro estimado será objeto de documento próprio.

Guilherme Thomé

Superintendente Médico · Provimento de Saúde

Unimed Governador Valadares · CRM-MG 64193 · RQE 41538

